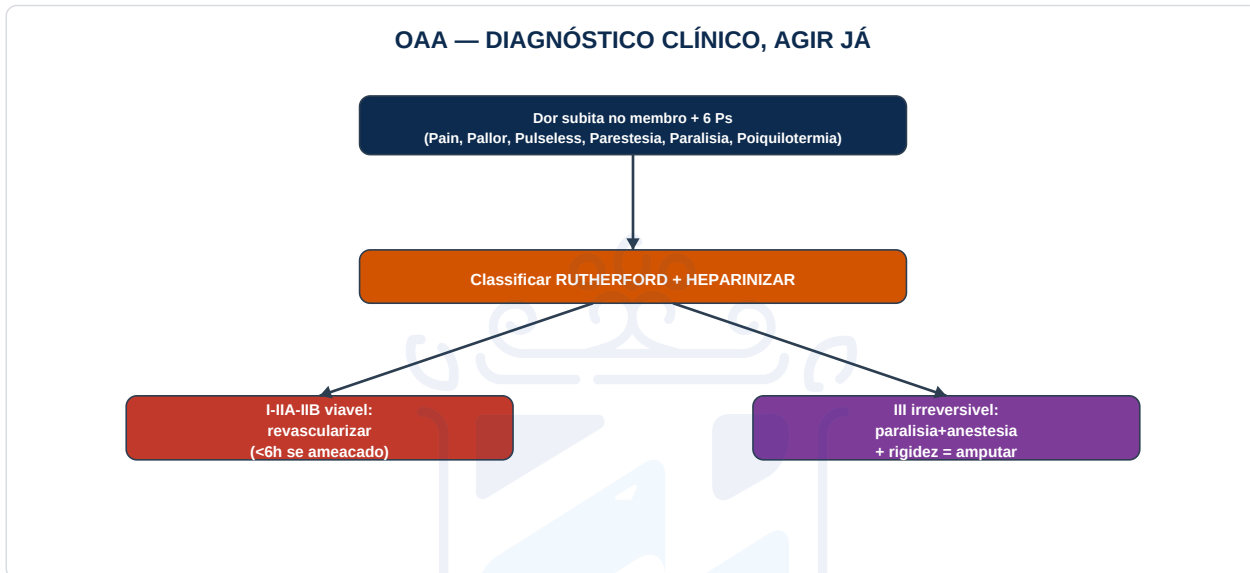


## OCCLUSÃO ARTERIAL AGUDA — TEMPO É MÚSCULO

### FLUXOGRAMA — 6 Ps E RUTHERFORD



### QUANDO SUSPEITAR — OS 6 Ps

#### RECONHECIMENTO RÁPIDO

- Pain (dor): início súbito, intensa no membro afetado
- Pallor (palidez): pele pálida, cerosa
- Pulselessness: pulso distal ausente/diminuído (COMPARAR com o contralateral)
- Paresthesia: formigamento, dormência
- Paralysis: fraqueza/incapacidade de mover (isquemia crítica)
- Poikilothermia (frieira): membro frio. Início < 6h = melhor prognóstico

### CLASSIFICAÇÃO DE RUTHERFORD

| Classe             | Achados                                                | Conduta           |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| I - Viável         | Sem déficit motor/sensitivo; não ameaçado              | Urgência (horas)  |
| IIA - Marginal     | Sem déficit motor, parestesia mínima                   | URGÊNCIA (< 6h)   |
| IIB - Imediato     | Fraqueza leve-moderada, perda sensitiva além dos dedos | EMERGÊNCIA (< 6h) |
| III - Irreversível | Paralisia completa, anestesia, rigidez muscular        | Amputação         |

### RED FLAGS — ISQUEMIA IRREVERSÍVEL (Rutherford III)

#### PROVÁVEL AMPUTAÇÃO

- Paralisia completa do membro + anestesia (perda total da sensibilidade)
- Rigidez muscular (contratura) — síndrome compartimental
- Marmóreo FIXO (livedo que não clareia à elevação)
- Rabdomiólise (urina escura, CPK elevada)
- Diagnóstico é CLÍNICO — não postergar conduta aguardando exames se isquemia grave

## ETIOLOGIA — EMBOLIA x TROMBOSE

| Característica       | Embolia (50-60%)                    | Trombose (30-40%)                 |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Início               | Súbito, dor intensa imediata        | Mais gradual (horas)              |
| Claudicação prévia   | Ausente                             | Presente (DAP crônica)            |
| Membro contralateral | Pulsos normais                      | Pulsos diminuídos bilateral       |
| Fonte/contexto       | FA (80%), IAM, prótese, endocardite | Aterosclerose, tabagismo, DM, HAS |

## CONDUTA — EMERGÊNCIA VASCULAR

### Rx MEDIDAS IMEDIATAS + HEPARINA

2 acessos calibrosos, O<sub>2</sub> se SatO<sub>2</sub> < 94%, analgesia (morfina fracionada / dipirona)  
Hidratação SF para manter diurese (prevenir rabdomiólise); JEJUM (provável cirurgia)  
Membro em posição neutra ou levemente em DECLIVE (NÃO elevar); proteger/acolchoar  
HEPARINA não fracionada JÁ (se sem contraindicação): bolus 80 UI/kg (máx 5.000) + 18 UI/kg/h em BIC  
Alvo TTPA 1,5-2,5x; contraindicações: sangramento ativo, AVCh recente, plaq < 50.000  
ACIONAR cirurgia vascular IMEDIATAMENTE — IIA/IIB = revascularizar em < 6h

## SÍNDROME DE REPERFUSÃO (pós-revascularização)

### ANTECIPAR E PREVENIR

- Liberação de metabólitos: acidose metabólica, HIPERCALEMIA (arritmia/PCR), mioglobínúria (IRA), SDRA
- Síndrome compartimental -> fasciotomia
- Hidratação vigorosa (200-300 mL/h SF); monitorar K+ rigorosamente
- Alcalinização (bicarbonato 1-2 mEq/kg se acidose grave); considerar manitol 0,5 g/kg
- Manter diurese > 0,5 mL/kg/h

## EXAMES (sem atrasar a conduta)

### ENQUANTO MOBILIZA A CIRURGIA

- Doppler arterial confirma ausência de fluxo e localiza — NÃO postergar tratamento para fazê-lo
- AngioTC/arteriografia: anatomia para planejar revascularização (se tempo permitir / no preparo)
- Laboratório: hemograma, coagulograma, ureia/creatinina, eletrólitos, CPK/mioglobina, gaso/lactato, ECG
- ECG: avaliar FA (fonte embólica); se suspeita de IAM, troponina + avaliação cardiológica

## INTERNAÇÃO

### TODOS OS CASOS INTERNAM

- ☐ Classe I: internação para revascularização programada (horas)
- ☐ Classe IIA/IIB: UTI/centro cirúrgico imediato (< 6h)
- ☐ Classe III: internação para amputação ou cuidados
- ☐ Se FA: controle de FC e anticoagulação prolongada após cirurgia
- ☐ Monitorar K+, função renal e diurese (reperfusão)

## MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

### RESUMO PARA REGULAÇÃO (EMERGÊNCIA)

- OAA de \_\_\_\_ (membro/artéria), início há \_\_\_\_ h. Rutherford \_\_\_\_.
- Pulsos \_\_\_\_; temperatura \_\_\_\_; sensibilidade \_\_\_\_; motricidade \_\_\_\_.
- Etiologia provável: embólica/trombótica.
- Heparina iniciada (dose) / não iniciada (motivo). ECG: FA/sinusal.
- NECESSITA REVASCULARIZAÇÃO URGENTE. Janela: \_\_\_\_ h. Transferência IMEDIATA para cirurgia vascular.



SM24  
Suporte ao Plantão Médico

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com FA, dor súbita e intensa em MID, palidez, frialdade, ausência de pulso pedioso e parestesia mínima sem déficit motor. Classificação e conduta?

- A) Rutherford III — amputação imediata
- B) Rutherford IIA — heparinizar e revascularizar com urgência (< 6h)
- C) Rutherford I — observar ambulatorialmente
- D) Não é oclusão arterial — alta
- E) Trombose venosa — anticoagular e alta

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado caracteriza isquemia IRREVERSÍVEL (Rutherford III)?

- A) Parestesia mínima
- B) Paralisia completa + anestesia + rigidez muscular
- C) Pulso diminuído com dor leve
- D) Palidez isolada
- E) Claudicação intermitente

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual medida deve ser iniciada imediatamente na oclusão arterial aguda, salvo contraindicação?

- A) Elevar o membro afetado
- B) Heparina não fracionada (bolus + manutenção em BIC)
- C) Antibiótico de amplo espectro
- D) Trombolítico oral
- E) Compressão do membro

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Após a revascularização, o paciente pode desenvolver hipercalemia, mioglobínúria e acidose. Como se chama essa complicação e qual medida a previne?

- A) Síndrome de reperfusão — hidratação vigorosa e monitorização do potássio
- B) Choque séptico — antibiótico
- C) Embolia gordurosa — corticoide
- D) Síndrome nefrótica — albumina
- E) Crise tireotóxica — betabloqueador

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre embolia x trombose como causa de OAA, é correto:

- A) A embolia cursa com claudicação prévia e pulsos contralaterais diminuídos
- B) A embolia tem início súbito, sem claudicação prévia, frequentemente por FA, com pulsos normais no membro contralateral
- C) A trombose tem início abrupto sem fatores de risco
- D) Ambas têm exatamente a mesma apresentação
- E) A trombose nunca ocorre em ateroscleróticos

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

Membro viável com parestesia mínima e sem déficit motor é Rutherford IIA (ameaçado marginal): heparinização imediata e revascularização urgente (< 6h). A fonte (FA) sugere embolia.

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

Rutherford III (irreversível) = paralisia completa + anestesia + rigidez muscular (e marmóreo fixo), indicando inviabilidade do membro e provável amputação.

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na OAA, inicia-se heparina não fracionada de imediato (bolus 80 UI/kg + 18 UI/kg/h em BIC, salvo contraindicação) para evitar propagação do trombo e embolia distal, enquanto se aciona a cirurgia vascular.

### QUESTÃO 4 → Resposta: A

A síndrome de reperfusão (acidose, hipercalemia, mioglobínúria, SDRA) ocorre após restaurar o fluxo. Previne-se com hidratação vigorosa, monitorização rigorosa do K+, alcalinização e atenção à síndrome compartimental.

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

A embolia (geralmente por FA) tem início súbito, sem claudicação prévia e com pulsos normais no membro contralateral; a trombose é mais gradual, em aterosclerótico com claudicação prévia e pulsos diminuídos bilateralmente.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico